

颞叶脑挫裂伤吸收期改变,但脑水肿肿胀较剧;双侧胸腔积液。腹部B超检查未见明显积液。于2010年8月31日开始,给予甘露醇注射液(安徽丰原药业股份有限公司,批号:09062034)130 ml+地塞米松磷酸钠注射液(天津药业焦作有限公司,批号:10060911)2.5 mg,iv qid;甘油果糖注射液(布瑞得,天津天安药业股份有限公司,批号:201001071)250 ml,iv bid。当日使用无任何不适。2010年9月8日继续静滴上述输液,滴速40滴/min。在输注甘油果糖注射液20 ml时,患者出现寒战、畏寒,T 36.3℃,P 72次/min,血压未测。立即停药,并静注地塞米松5 mg,30 min后症状缓解,2 h后无任何不适。

讨论 甘油果糖注射液是高渗制剂,通过高渗透性脱水,能使脑水分含量减少,降低颅内压。本品降颅内压作用起效较缓,持续时间较长,临床主要用于脑血管病、脑外伤、脑肿瘤、颅内炎症及其他原因引起的急慢性颅内压增高,脑水肿等。

本例患者无药物过敏史,使用甘露醇和甘油果糖连续静滴8d未见任何不适。在第9天输注甘露醇结束后,继续输注甘油果糖20 ml时患者出现寒战、畏寒症状,从时间上有相关性,因此考虑与甘油果糖相关。同时,患者换药未见红肿热痛等迹象,可排除感染引起。因此重点怀疑为甘油果糖引起的寒战。甘油果糖药品说明书中载明“本品一般无不良反应,偶可出现溶血现象。”临床上关于本品的不良反应的报道不多,常见的有皮疹瘙痒^[1]、静脉炎^[1-3]、溶血反应^[4]等,还有1例因静脉滴注甘油果糖渗漏引起皮下组织坏死^[5]的报道。因本

品为复方制剂,其组分为甘油、果糖、氯化钠和注射用水。曾有报道果糖注射液可致过敏性休克^[6],因此本例不良反应的发生可能也与本品所含果糖成分有关。也不排除与患者为过敏体质或年龄大、久病后机体抵抗力下降等有关。

本例提示临床在使用甘油果糖时须注意:①用药前注意询问患者过敏史,应向患者说明该药的个体差异(血管通透性、年龄等),对可能出现的血管反应,做好耐心的解释,取得患者的配合。②对有遗传性果糖不耐症患者禁用;对严重循环系统机能障碍、尿崩症、糖尿病患者慎用。③临床使用时注意滴速,一般为10~20滴/min,滴注过程中应加强巡视和观察。④患者出现ADR应立即报告医师,及时对症处理。密切注意患者ADR缓解情况,防止严重不良后果发生。

参 考 文 献

- 1 陈嘉凤,何伟珍.甘油果糖不良反应分析[J].海峡药学,2009,21(6):228-229
- 2 周伟元.甘油果糖致静脉炎的预防[J].中国乡村医药杂志,2010,17(5):48
- 3 黄芳芳,金红,李波.甘油果糖注射液在骨科应用中出现静脉炎的护理体会[J].现代中西医结合杂志,2010,19(1):114-115
- 4 李钊,梁福乐.甘油果糖致溶血反应1例[J].现代医药卫生,2005,21(2):167
- 5 尚晓霞,吴亚丽,李林艳.静脉输注甘油果糖渗漏引起皮下组织坏死1例的护理干预[J].中国误诊学杂志,2005,5(16):3158
- 6 孔飞飞,谭兴起.果糖注射液致过敏性休克[J].药物流行病学杂志,2010,19(8):484-485

(2010-10-18 收稿 2011-01-05 修回)

[通讯作者]谭兴起, Tel:13587219072, E-mail:tanxq@sohu.com

抗抑郁药:换用抗抑郁药时 发生药物相互作用的风险

澳大利亚ADRAC发出警告称,关于换用抗抑郁药时可能因药物相互作用而影响转归,包括发生5羟色胺综合征。抗抑郁药包括选择性5羟色胺再摄取抑制药(SSRI)、三环类抗抑郁药(TCA)、单胺氧化酶抑制药(MAOI)、去甲肾上腺素及5羟色胺受体拮抗药、5羟色胺及去甲肾上腺素再摄取抑制药(SNRI)、去甲肾上腺素再摄取抑制药及中草药。

ADRAC声称,5羟色胺综合征是所有抗抑郁药在更换药物治疗或中断原用药物时均可发生的潜在药物不良事件,尤其是老年人。如果同时用1种以上抗抑郁药,则5羟色胺综合征增加。ADRAC忠告医师们,如须换用其他抗抑郁药时,应有适当清洗期或逐渐减药期。

西格列汀:修订该药处方及其致急性胰腺炎信息

美国FDA已忠告医师及广大病人,关于修订西格列汀

(sitagliptin)及西格列汀/二甲双胍处方,包括用该药后发生急性胰腺炎报告的信息。西格列汀为二肽酶-4(DPP-4)抑制剂,原批准用于配合控制饮食及运动,以控制成人2型糖尿病患者的血糖。FDA称该药上市后,于2006年10月~2009年2月已收到88例急性胰腺炎的报告,包括2例出血性或坏死性胰腺炎。建议职业医务工作者,在开始使用该药或增加该药剂量时,应严密监测,一旦怀疑发生胰腺炎应立即停药,特别要注意过去曾有胰腺炎病史者的用药监测。

阿仑膦酸盐:致抗股骨骨折 能力低下

新西兰Medsafe已忠告医师,要考虑阿仑膦酸盐治疗后,发生不典型应力性骨折,其症状为转子下或邻近的骨骼疼痛。Medsafe建议,如怀疑骨折,必须作双侧股骨X线摄片,因为该药引起的骨折常是双侧的。该药增加骨折风险的原因包括:维生素D缺乏或吸收不良、使用糖皮质激素,有应力性骨折既往史、下肢关节炎或一般骨折史、剧烈运动或运动量增加、糖尿病及长期酒精滥用。

(WHO全球药物不良反应信息 蔺彦章摘译 杨金祥校译)